CME开展模式

场景	模式	赢利点	难点	推荐
自建平台	B2B2C 生态平台模式	赞助费	学分认可 如何成为继教项目	可尝试
自建平台	线上平台定制模式	技术服务费	收入不会很高；学分认可	并行做，不矛盾
自建平台	数据驱动的知识聚合与个性化推荐模式	知识付费	合作难度大，起点太高	一般
自建平台	细分市场，垂直领域	用户付费	扩大用户规模的能力；学分认可；	建议做
平台赋能	B端赋能与服务	服务费	技术能力与运营能力	建议做
平台赋能	C端增值服务	服务费		建议做
代理模式	局部代理	用户付费分成	预计收入一般	可尝试
代理模式	全国代理	用户付费分成	看甲方意愿	建议做
信息化建设	省级管理系统	卡位用，费用低	看天时地利人和，推翻重建的难度非常大	能做最佳，但需要长期跟进
信息化建设	省级远程机构管理系统	卡位用，费用低	需要有充足的理由（利益）说明地方做这个平台	能做最佳

一、自建平台

公司自己建设平台，亲自下场参与CME市场

1.1 B2B2C 生态平台模式

公司自己打造一个连接多方主体的教育服务平台。

- **运作思路**：与药企、医疗器械厂商合作，由其赞助课程费用（厂商可借此进行合规学术推广），向医生供低成本甚至免费的高质量继续教育课程。
- **好处**：
  - **对医生**：获得免费或低成本、高质量的学习资源，完成学分要求，提升技能。

    - **对药企/器械厂商**：构建了精准、合规的学术推广和品牌建设渠道，能触达目标医师群体。
    - **对公司**：快速获取用户，形成规模效应，通过赞助费、数据增值服务（脱敏后的学习行为分析报告）等方式盈利。
- **难点：
    - 强大的课程开发和内容质量把控能力
    - 与足够多的药企/器械厂商建立合作关系：我们怎么找到厂商。
    - **如何解决学分问题**：平台怎么对接国家管理平台，各省怎么认我们平台的信息。
    - 平台的技术支撑和用户体验

1.2 线上平台定制模式

为医疗机构、行业组织提供**定制化的专属继续教育平台**。

- **运作思路**：为医院或行业组织部署其独立的线上培训学院（含其品牌标识），根据其特定需求（如专科特色、新技术培训、院内规范流程）定制课程体系。
- **好处：**
    - **对医疗机构、行业组织：拥有了一个能高效、系统化培训员工（尤其是医护人员）的线上平台**，同时解决学分问题。
    - **对公司：** 公司作为技术支持单位，为甲方提供**长期解决方案**”，甲方支付系统使用费、内容更新费和运维服务费。（这种费用估计每个合作单位的金额不会太大）
- **难点：**
    - 深度理解医疗机构培训需求、
    - 快速定制和部署的能力、
    - 提供持续优质的内容更新服务。
    - **解决学分问题**
- **案例：**
    - 中国人体健康促进会：目前对方把协议发我了，我们还未过法务，一直在问我今年什么时候可以报远程项目。

1.3 数据驱动的知识聚合与个性化推荐模式

利用大数据和人工智能，成为医学继续教育领域的“知识管家”。

- **运作思路**：并不完全侧重于自产内容，而是利用技术**聚合 + UGC、筛选、标签化全网优质的医学继续教育资源**（包括其他机构的课程、公开课、学术文献、指南解读等）。通过AI算法为每位医生构建个性化学习画像，实现“**千人千面**”的精准课程推荐和学习路径规划。
- **好处：**
    - **对医生**：节省了大量搜寻和筛选信息的时间，能获得真正贴合自身专业领域、能力短板和兴趣点的学习内容，提升学习效率。

    - **对公司：** 轻资产运营模式，核心竞争力在于技术算法和用户体验。可通过会员订阅费（获取无限制个性化推荐和完整学习体验）、联盟营销（导流其他平台课程并获得分成）等方式盈利。
- **难点**：
    - 技术能力：强大的信息聚合和算法推荐能力
    - 与众多内容提供方建立合作关系
    - 对医学知识体系的深度理解。
- **案例**：
    - 丁香医生

1.4 细分市场，垂直领域

- **运维思路：**
    - **细分市场切入**：作为新进入者，避免与头部平台全面竞争。可选择一个**细分专科领域**（如睡眠等）或**特定区域市场**深耕，建立口碑和样板案例
    - **合作共赢**：积极与**医学协会、学会、知名医院、专家**建立合作关系，联合开发课程，提供**从理论学习到技能实操、考核认证的一体化深度解决方案**，获取学分授予资质，这是提升课程吸引力和权威性的关键。
    - **试点验证**：选择一两种模式进行小范围试点，收集用户反馈和数据，验证商业模式的可行性和盈利性，再逐步放大。
- **价值主张**：
  - **对医生**：获得某个细分领域极具针对性和深度的权威培训，提升专业竞争力。证书+学分 双收获
  - **对医院/卫健委**：获得一套能系统化、规模化培养特定紧缺人才或提升专项能力的工具，降低成本。
  - **对公司**：建立专业壁垒，获得更高客单价和用户粘性。直接自己做培训市场，直接向学员收费，单价更高，收入关键看人员规模。
- **难点：
    - 顶尖的专科专家资源
    - 深度的课程研发和实操设计能力
    - 与相关认证机构的合作
    - 解决学分获得的问题
    - 解决在怎么在更多地区开展的问题
- **案例：**
    - 睡眠：当前需要怎么让睡眠项目成为远程项目（需要省里推荐，无法直报），其次可以利用我们已有的睡眠基地在全国开展，但是要解决各地的学分获取问题。

二、平台赋能型生态模式

不与其他内容提供商（如华医网、好医生）直接竞争，而是应成为 **“平台的平台”、“生态的构建者”**。
前提优势：

1. **官方背书与权威性**：作为国家卫健委指定的全国学分管理平台，具有极高的**公信力和权威性**，这是任何市场参与者都无法比拟的核心优势。
2. **数据中枢与流量入口**：平台将汇聚全国医务人员的**学习行为数据、学分获取数据**，成为整个继续医学教育生态的**数据中枢和天然流量入口**。
3. **标准制定与生态位势**：您处于规则执行层，能最早理解政策动向，甚至可能参与后续细则的讨论，有能力为行业提供**合规性咨询和解决方案**。
4. **网络效应潜力**：所有的项目主办方（高校、医院、学会、企业）都需要接入您的平台进行学分登记与认证；所有的医务人员都需要使用您的平台查询和管理学分。这将形成强大的**双边网络效应**。
   思路：
   利用平台垄断地位，通过赋能各方，建立行业标准，最终成为不可或缺的生态基础设施。

2.1：B端赋能与服务

为各类项目主办方（B端）提供增值工具和服务，帮助他们更好的开展业务。

- **服务内容**：
  1. **SaaS工具包**：向医院、学会、内容机构提供“**在线培训工具包**”，包括高清直播、在线考试、AI监考（防作弊）、学习进度管理、电子发票等一站式解决方案。降低他们开展线上培训的技术门槛和成本。
  2. **合规咨询与解决方案**：为**药企/器械厂商**提供绝对的合规保障。它们的学术推广需求巨大，但最怕违规。您可以提供一套**全流程合规的学术推广+医生教育解决方案**，确保其赞助的课程从内容、形式到学分发放完全符合《规定》要求。
  3. **精准推广与效果评估**：利用平台数据（**脱敏后**）帮助12家远程机构（如华医网，好医生）进行精准的课程推送，并提供详尽的、可量化的**学习效果评估报告、行业洞察报告**（如：覆盖了多少目标科室医生、平均学习时长、考核通过率等），证明其学术投入的价值。
  4. **精品课程评选或共建**：“精品课程”精准推送，优先展示。
- **收入**：
  - **SaaS服务年费**（向项目主办方收取）。
  - **高端解决方案咨询费**（向药企/器械厂商收取）。
  - **精准营销与数据报告服务费**（向药企/器械厂商收取）。
- **想法：**
  - **在线培训工具包：** 数据上传工具（他们有大量的数据要上传）、播放器（我们有一个）；
  - **合规咨询与解决方案：** 怎么让他们的项目通过评审，这个桌面上没法明说。
  - **精准推广与效果评估：** 各类数据分析，比如哪个学科需求最高，学习人数最多等等；但是考验技术水平与运营能力

2.2：C端增值服务（难度大，但不防一试）

面向广大医务人员（C端），提供个性化服务，增强用户粘性。

- **内容**：
  1. **个性化学习导航**：基于用户的学分状况、专业领域、学习历史，利用AI算法为其**智能推荐最合适、最高效的课程组合**，帮助其快速完成年度学分要求。
  2. **学术与知名度提升服务**：与垂直领域互联网平台合作（丁香园等），为完成特定高端培训或学分类别突出的医生提供**学术与知名度提升服务**。
- **收入**：
  - **高级会员订阅费**（享受个性化导航、精选课程包等）。
  - **流量费**（向垂直领域互联网平台收取）。
- **思路：**
  - 第一步：自建一个面向C端的平台，然后向继教中心申请管理平台的对接。（规避中心的风险，把事情放到面上说），理由：服务行业，不强制。
  - 第二步：可以和各项目主办方谈项目聚合的事情（实际上管理平台让学员先到管理平台选择项目，再跳转到各自远程平台是很麻烦的事情，一是管理平台没有精准分析与推送的能力，学员找项目很麻烦的）
  - 第三步：面向学员提供精准的项目推送，学员信息从管理平台获得。可直接学习。
  - 第四步：可推送信息给管理平台，项目课程是哪方的，我们就按哪方的身份向管理平台推送（规避了我们成为第13家的问题，我们只是数据的“中转站”与“搬运工”。

三、代理模式

博奥利用自身地位优势，为各机构做代理。

3.1：做机构的部分区域代理

如举名等新兴远程机构，他们要做到其他地区很难，我们可以做他的代理。

3.2：做全国代理

目前有一些远程机构只做了自己内部的远程培训，其实它的资质有点“浪费”了，我们可去谈全国代理，我们来推广，如：北大医学院，川大华西医院等。

四、信息化建设（助攻）

通过信息化建设，来获取业务拓展的卡位优势。

4.1 给各省建议省级继续教育管理平台（难度极大）

各省基本都已经建立自己的省级平台，虽然部分地区平台老旧，但是历史数据很大，更换系统的难度比较大。但是有机会，一定要参与。

4.2 建议各省建议远程机构的同质化管理平台（建议）

当前各省的管理平台主要是对省级的项目（且主要是面授项目）进行管理，但是对于远程项目特别是国家级项目，他们是不太管的。在机构放开、学分从国家获得的情况下，意味着他们不得不接受可能未备案的机构的学分。那么是否可以建立一个远程机构在当地的备案、过程管理与学分获取的平台。这样对于省级主管部门来说，只要有这个平台，其他衔接都是顺畅的。